

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ (ΣΩΜΑΤΟΣ) ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου συμβαίνουν κυρίως στο μέσο τριτημόριο του οστού και ο μηχανισμός κάκωσης είναι άμεση πλήξη, πτώση πάνω στην παλάμη με το άνω άκρο σε έκταση, πτώση πάνω στον αγκώνα και σε τροχαία ατυχήματα. Σε ασθενείς με δευτεροπαθείς εντοπίσεις στο βραχιόνιο, εμφανίζονται ως παθολογικά κατάγματα.

Τα κατάγματα αυτά όταν προκαλούνται από άμεση βία, είναι εγκάρσια, λοξά ή συντριπτικά, ενώ όταν προκαλούνται από άσκηση έμμεσης βίας (πτώση πάνω στην παλάμη με τεντωμένο το άνω άκρο και στροφή κατά τον επιμήκη άξονα) είναι σπειροειδή. Λοξό ή εγκάρσιο κάταγμα βραχιονίου μπορεί να προκληθεί και από πτώση πάνω στον αγκώνα.

Δεν απαιτείται ανατομική ανάταξη για την επίτευξη αποτελεσματικής θεραπείας των καταγμάτων αυτών. Αρκεί να υπάρχει καλός άξονας σύγκλεισης και επαρκής επαφή των επιφανειών του εγκάρσιου κατάγματος (κατά 1/2 ή ακόμα και κατά 1/3).

Ενίοτε, στις κακώσεις αυτές μπορεί να προκληθεί **παράλυση του κερκιδικού νεύρου** σε ποσοστό 15-20%, επειδή το νεύρο έρχεται σε επαφή με το οστό κατά την πορεία του εντός της σπειροειδούς αύλακος του βραχιονίου. Η παράλυση εκδηλώνεται με αδυναμία στην έκταση του καρπού και των δακτύλων, καθώς και με υπαισθησία στο έξω ημιμόριο της ράχης του καρπού, η οποία αποκαθίσταται σταδιακά σε χρονικό διάστημα 3-6 μηνών.

Τα λοξά και τα σπειροειδή κατάγματα του σώματος του βραχιονίου φαίνεται να έχουν καλύτερη πρόγνωση και η αντιμετώπισή τους είναι κατά κανόνα συντηρητική.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. **Ακινητοποίηση** του άκρου με κάθε τρόπο. Προ των όποιων χειρισμών μας, απαραίτητη είναι η μέτρηση των **ζωτικών σημείων** (BP, HR, RR, SpO₂, T^oC), ο έλεγχος για πιθανές συννοσηρότητες (AY, ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.) και κυρίως η χορήγηση **αναλγησίας**, όπως κάτωθι.
2. Χορηγούμε 1 amp. Apotel-plus (im) ή 1 fl. 100 ml Apotel 1gr (iv - στάγδην).
3. Επί ενδείξεων χορηγείται 1 amp. Voltaren (im), (ή Dynastat ή Xefo ή Vixaxal, ενδομυϊκά ή βραδέως ενδοφλεβίως σε 100 ml N/S), καθώς και 1 amp. Musco-Ril (ή Norflex) (im). Εναλλακτικά, 1 fl Combogesic (1 g/300 mg) 100 ml (iv) και 1 amp. Musco-Ril (im).
4. Μεριμνούμε για γαστροπροστασία, με χορήγηση 1 amp. Σιμετιδίνης 200 mg (Tagamet) σε 100 ml N/S (ή im), ή/και χορήγηση 1 amp. PPI (Nexium/Lodin) σε iv-bolus έγχυση.
5. Σκοπός της ανάταξης και γενικότερα της θεραπείας ενός κατάγματος βραχιονίου είναι η λειτουργική αποκατάσταση. Η τελευταία δεν προϋποθέτει απαραίτητως και ανατομική αποκατάσταση. Επιπλέον, η πόρωση στα λοξά και στα σπειροειδή κατάγματα δεν παρουσιάζει δυσκολίες, επειδή έχουν μεγάλες επιφάνειες επαφής. Για αυτόν το λόγο, στο μεγαλύτερο ποσοστό, η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών είναι συντηρητική.
6. Ανάταξη και εφαρμογή γύψινου νάρθηκα σε σχήμα “U” είτε με νάρκωση ή και χωρίς νάρκωση. Ο νάρθηκας αρχίζει άνω και έξω από το ακρώμιο και κατεβαίνοντας περνάει γύρω από τον αγκώνα καταλήγοντας προς τα άνω και έσω στη μασχάλη. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα περιορισμένων κινήσεων στον αγκώνα και στον ώμο.
7. Αν πρόκειται να διακομίσουμε στο νοσοκομείο (σε Ορθοπαιδική κλινική), τοποθετούμε αερονάρθηκα air splint ή γυψονάρθηκα (ραχιαίο, αφού πρόκειται για το άνω άκρο).
8. Σε επιπεπλεγμένο (ανοικτό) κάταγμα του βραχιονίου, ενεργούμε επίσης ως εξής:
 - ▶ Ανοσοποιούμε για τέτανο, χορηγώντας HTIG: inj. Tetagam-P 250 IU, ενδομυϊκά.
 - ▶ Λαμβάνουμε καλλιέργειες του τραύματος, με ειδικό στελεό (τύπου Stuart).
 - ▶ Επιτελούμε σχολαστική έκπλυση του τραύματος, με άφθονο ισότονο ορό.
 - ▶ Προβαίνουμε σε προσεκτική αφαίρεση ξένων σωμάτων (παρασχίδες, θραύσματα).
9. Παραπομπή στο νοσοκομείο για ανάταξη και ακτινογραφικό έλεγχο εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα. Πιθανώς σε επιπεπλεγμένα κατάγματα να χρειαστεί νοσηλεία, ειδικά αν υπάρχουν συννοσηρότητες. Όταν η παρεκτόπιση είναι μεγάλη και χρειάζεται ανάταξη, είναι επιθυμητό, όχι όμως και απαραίτητο, τα δύο τμήματα να αναταχθούν ανατομικά.